THÈME • Santé et qualité de vie

FACILE

Q01 · La psychologie de la santé étudie notamment…

- ☐ A. les seuls résultats biologiques.
- ☐ B. les déterminants biologiques, psychologiques et sociaux.
- ☐ C. le vécu subjectif de la maladie.
- ☐ D. uniquement la prescription médicale.
- ☐ E. les comportements de santé.

FACILE

Q02 · Que faut-il retenir de la définition de la santé formulée par l'OMS ?

- ☐ A. Elle inclut le bien-être physique.
- ☐ B. Elle se réduit à l'absence de maladie.
- ☐ C. Elle inclut le bien-être mental et social.
- ☐ D. Elle impose une mesure biologique unique.
- ☐ E. Sa notion de « complet bien-être » peut être discutée.

MOYEN

Q03 · À propos de la santé perçue, quelles propositions sont justes ?

- ☐ A. Elle correspond à l'évaluation que le patient fait de sa propre santé.
- ☐ B. Elle est toujours identique aux examens.
- ☐ C. Elle dépend du vécu personnel.
- ☐ D. Elle peut différer de l'évaluation des professionnels.
- ☐ E. Elle exclut les émotions.

FACILE

Q04 · Quelles dimensions font partie de la qualité de vie ?

- ☐ A. le fonctionnement physique.
- ☐ B. la situation sociale.
- ☐ C. les ressources et le logement.
- ☐ D. uniquement les constantes vitales.
- ☐ E. exclusivement la durée du traitement.

MOYEN

Q05 · Une personne vit avec une maladie chronique et dit garder une bonne qualité de vie. Que peut-on conclure ?

- ☐ A. Cette appréciation peut être authentique.
- ☐ B. Elle prouve l'absence de maladie.
- ☐ C. La qualité de vie est subjective et multidimensionnelle.
- ☐ D. Les professionnels doivent nécessairement la corriger.
- ☐ E. L'évaluation personnelle doit être entendue.

DIFFICILE

Q06 · Lorsqu'une infirmière et un patient évaluent différemment la santé de ce dernier…

- ☐ A. l'hétéro-évaluation peut différer de l'auto-évaluation.
- ☐ B. il faut exclure la parole du patient.
- ☐ C. il faut explorer les raisons de l'écart.
- ☐ D. la perception du patient devient forcément fausse.
- ☐ E. les deux regards peuvent éclairer la situation.

THÈME • Maladie, douleur et représentations

FACILE

Q07 · Dans la distinction disease / illness / sickness, illness désigne…

- ☐ A. l'expérience subjective de la maladie.
- ☐ B. la seule classification diagnostique.
- ☐ C. le sens vécu et exprimé par la personne.
- ☐ D. exclusivement l'évolution biologique.
- ☐ E. un concept identique au terme disease.

FACILE

Q08 · La notion de sickness se rapporte notamment…

- ☐ A. à la reconnaissance sociale de la maladie.
- ☐ B. à la stigmatisation éventuelle.
- ☐ C. aux relations entre maladie et contexte culturel.
- ☐ D. uniquement à une prise de sang.
- ☐ E. seulement à la douleur ressentie.

MOYEN

Q09 · Quelles affirmations correspondent à l'approche de la douleur présentée ?

- ☐ A. Elle comporte une dimension sensorielle.
- ☐ B. Une douleur nécessite toujours une lésion prouvée.
- ☐ C. Elle comporte une dimension émotionnelle.
- ☐ D. Une absence d'anomalie à l'examen permet de la nier.
- ☐ E. Elle est personnelle et subjective.

DIFFICILE

Q10 · Un patient exprime une douleur sans anomalie identifiée. Quelle posture est adaptée ?

- ☐ A. Accueillir la plainte sans disqualification.
- ☐ B. Dire que le patient simule.
- ☐ C. Évaluer et transmettre le vécu douloureux.
- ☐ D. Déduire que la cause est exclusivement psychique.
- ☐ E. Chercher une prise en charge adaptée.

MOYEN

Q11 · Les représentations personnelles de la maladie peuvent concerner…

- ☐ A. sa cause supposée.
- ☐ B. son avenir et sa durée.
- ☐ C. les possibilités de la contrôler.
- ☐ D. seulement son code diagnostique.
- ☐ E. uniquement les paroles du soignant.

DIFFICILE

Q12 · Une personne associe sa maladie à une épreuve familiale et refuse un soin. Que doit faire le soignant ?

- ☐ A. Explorer le sens donné à la maladie.
- ☐ B. Conclure à une mauvaise volonté certaine.
- ☐ C. Distinguer croyance personnelle et cause médicalement établie.
- ☐ D. Nier immédiatement toute inquiétude.
- ☐ E. Rechercher les besoins de contrôle du patient.

THÈME • Déterminants et modèle intégratif

FACILE

Q13 · Quels niveaux sont articulés dans le modèle intégratif de la santé ?

- ☐ A. des prédicteurs.
- ☐ B. des modérateurs transactionnels.
- ☐ C. des issues ou critères d'ajustement.
- ☐ D. uniquement une cause génétique.
- ☐ E. une certitude de maladie à partir d'un seul facteur.

MOYEN

Q14 · Un facteur de risque…

- ☐ A. augmente une probabilité sans déterminer le destin individuel.
- ☐ B. permet de prédire à coup sûr un diagnostic.
- ☐ C. peut être personnel ou environnemental.
- ☐ D. doit être distingué d'un déclencheur ou stresseur.
- ☐ E. rend inutile l'étude des ressources protectrices.

MOYEN

Q15 · Parmi les éléments suivants, lesquels sont des déterminants socio-environnementaux abordés ?

- ☐ A. la qualité du logement.
- ☐ B. l'accès aux soins.
- ☐ C. les ressources économiques.
- ☐ D. une affirmation que la culture suffit à expliquer une maladie.
- ☐ E. l'absence de toute inégalité de santé.

DIFFICILE

Q16 · Une personne fait face à la même contrainte qu'une autre mais la vit différemment. Qu'est-ce qui l'explique dans ce modèle ?

- ☐ A. la façon d'évaluer la situation.
- ☐ B. les ressources perçues et mobilisées.
- ☐ C. l'histoire personnelle.
- ☐ D. une réaction obligatoirement identique pour tous.
- ☐ E. l'impossibilité d'agir sur l'expérience du stress.

THÈME • Soutien social

FACILE

Q17 · Le réseau social d'une personne correspond…

- [ ] A. aux personnes avec lesquelles elle entretient des relations.
- [ ] B. à une garantie de soutien utile.
- [ ] C. à l'ensemble de ses contacts et liens.
- [ ] D. au sentiment d'être aidée uniquement.
- [ ] E. exclusivement aux professionnels de santé.

MOYEN

Q18 · Le soutien social perçu désigne…

- [ ] A. l'appréciation subjective de la disponibilité d'une aide.
- [ ] B. uniquement le nombre de contacts.
- [ ] C. le sentiment de pouvoir compter sur un soutien adapté.
- [ ] D. une mesure obligatoirement égale au soutien reçu.
- [ ] E. la qualité de l'aide telle que la personne l'imagine.

MOYEN

Q19 · Le soutien social reçu et le soutien mobilisé se distinguent parce que…

- [ ] A. le soutien reçu correspond à l'aide effectivement apportée.
- [ ] B. le soutien mobilisé implique une démarche de sollicitation.
- [ ] C. ils sont toujours identiques au soutien perçu.
- [ ] D. ils ne concernent jamais l'aide matérielle.
- [ ] E. une personne peut solliciter du soutien sans se sentir soutenue.

FACILE

Q20 · Quelles situations correspondent à des formes de soutien social ?

- [ ] A. Une aide matérielle pour le logement.
- [ ] B. Une écoute empathique.
- [ ] C. Une information pratique pour décider.
- [ ] D. Une relation nécessairement contraignante.
- [ ] E. L'obligation de n'obtenir que l'aide familiale.

DIFFICILE

Q21 · Une personne a beaucoup de connaissances mais dit « personne ne m'aide quand ça va mal ». Quelles pistes sont pertinentes ?

- ☐ A. Explorer la qualité du soutien perçu.
- ☐ B. Déduire automatiquement que son soutien est suffisant.
- ☐ C. Distinguer quantité de relations et disponibilité réelle.
- ☐ D. Examiner la possibilité de demander une aide adaptée.
- ☐ E. Répondre que son ressenti est faux car son carnet d'adresses est rempli.

THÈME • Vulnérabilité et résilience

FACILE

Q22 · La vulnérabilité peut dépendre…

- ☐ A. de caractéristiques individuelles.
- ☐ B. du contexte relationnel et socio-économique.
- ☐ C. de ressources et carences de l'environnement.
- ☐ D. uniquement de l'âge.
- ☐ E. exclusivement de la volonté.

MOYEN

Q23 · La résilience présentée en cours…

- ☐ A. suppose qu'une épreuve ou une adversité a été rencontrée.
- ☐ B. signifie une invulnérabilité permanente.
- ☐ C. renvoie à la capacité de poursuivre une construction.
- ☐ D. peut mobiliser des ressources extérieures.
- ☐ E. garantit l'absence de souffrance.

MOYEN

Q24 · À propos des formulations de Rutter et de Cyrulnik…

- ☐ A. elles insistent sur la poursuite du développement ou de la vie après l'adversité.
- ☐ B. une citation partielle suffit à l'examen selon Mme Katir.
- ☐ C. Plusieurs définitions de la résilience sont complémentaires.
- ☐ D. leurs formulations sont à restituer en phrases complètes.
- ☐ E. elles excluent les facteurs environnementaux.

MOYEN

Q25 · Les travaux longitudinaux d'Emmy Werner sont évoqués pour…

- ☐ A. illustrer des trajectoires adaptées malgré certains facteurs de risque.
- ☐ B. affirmer que tous les enfants exposés deviennent malades.
- ☐ C. montrer l'importance de facteurs protecteurs.
- ☐ D. établir que la résilience est identique pour tous.
- ☐ E. aider à réfléchir au devenir dans le temps.

DIFFICILE

Q26 · Que peut-on affirmer au sujet des traits de personnalité et de l'hostilité ?

- ☐ A. Un trait isolé ne permet pas d'établir qu'il cause une maladie.
- ☐ B. L'hostilité associe des composantes cognitives, émotionnelles et comportementales.
- ☐ C. Une attitude hostile justifie un jugement moral du soignant.
- ☐ D. La méfiance peut modifier l'évaluation d'une situation.
- ☐ E. Un trait rend toute intervention inutile.

THÈME • Stress et coping

FACILE

Q27 · Dans le modèle transactionnel du stress, l'évaluation primaire porte sur…

- ☐ A. la signification de la situation pour la personne.
- ☐ B. les ressources disponibles exclusivement.
- ☐ C. une menace, une perte ou un défi.
- ☐ D. le diagnostic biologique certain.
- ☐ E. l'appréciation de l'événement vécu.

MOYEN

Q28 · L'évaluation secondaire concerne notamment…

- ☐ A. les ressources personnelles estimées.
- ☐ B. les aides sociales disponibles.
- ☐ C. les possibilités d'agir.
- ☐ D. la nature anatomique obligatoire de la maladie.
- ☐ E. la certitude de maîtriser tous les événements.

MOYEN

Q29 · Le contrôle perçu…

- [ ] A. renvoie à une représentation de sa capacité d'agir.
- [ ] B. est toujours identique au contrôle objectif.
- [ ] C. peut porter sur les conséquences de la situation.
- [ ] D. peut porter sur ses propres réactions.
- [ ] E. rend toujours inutile le soutien des proches.

FACILE

Q30 · Le coping centré sur le problème peut consister à…

- [ ] A. chercher des informations fiables.
- [ ] B. planifier une action possible.
- [ ] C. agir concrètement sur la difficulté.
- [ ] D. nier obligatoirement toute réalité.
- [ ] E. considérer toute émotion comme interdite.

FACILE

Q31 · Le coping centré sur l'émotion peut inclure…

- [ ] A. une réévaluation positive.
- [ ] B. des stratégies de mise à distance.
- [ ] C. des efforts pour gérer la réponse émotionnelle.
- [ ] D. uniquement la réparation du problème matériel.
- [ ] E. le refus de ressentir toute émotion comme définition unique.

MOYEN

Q32 · Le coping centré sur la recherche de soutien comprend…

- [ ] A. demander une écoute.
- [ ] B. chercher des conseils.
- [ ] C. solliciter une aide matérielle.
- [ ] D. ne jamais parler à l'entourage.
- [ ] E. remplacer systématiquement la décision médicale par l'opinion d'un proche.

DIFFICILE

Q33 · Comment distinguer les stratégies de coping et les mécanismes de défense ?

- [ ] A. Le coping est décrit comme des efforts cognitifs et comportementaux d'ajustement.
- [ ] B. Les mécanismes de défense sont présentés comme largement inconscients.
- [ ] C. Ils sont exactement synonymes.
- [ ] D. La pertinence d'une stratégie dépend du contexte.
- [ ] E. Toute stratégie de coping est toujours efficace.

THÈME • Angoisse et mécanismes de défense

FACILE

Q34 · Les mécanismes de défense ont principalement pour fonction…

- [ ] A. de protéger le psychisme face à une angoisse ou un conflit difficile.
- [ ] B. de garantir l'absence de maladie.
- [ ] C. de ménager parfois du temps pour intégrer l'événement.
- [ ] D. de refléter des processus essentiellement inconscients.
- [ ] E. de prouver une mauvaise volonté du patient.

MOYEN

Q35 · Un patient paraît dans le déni après une annonce. Quelles attitudes sont cohérentes avec le cours ?

- [ ] A. Respecter la fonction potentiellement protectrice de la défense.
- [ ] B. Forcer immédiatement toute prise de conscience.
- [ ] C. Évaluer l'impact du déni sur la sécurité et l'accès aux soins.
- [ ] D. Écouter avant d'interpréter.
- [ ] E. Qualifier le patient de manipulateur.

MOYEN

Q36 · La projection peut être décrite comme…

- [ ] A. l'attribution à l'extérieur de pensées ou affects refusés en soi.
- [ ] B. une simple demande de précision.
- [ ] C. un mécanisme dont l'expression peut prendre la forme de reproches.
- [ ] D. une preuve que les soignants sont réellement responsables de toute difficulté.
- [ ] E. un mécanisme de défense évoqué en cours.

MOYEN

Q37 · À propos de la régression et de la rationalisation…

- [ ] A. la régression renvoie à des modes de fonctionnement antérieurs.
- [ ] B. la rationalisation produit une justification apparemment logique masquant des motifs inconscients.
- [ ] C. ces mécanismes s'expriment toujours consciemment et volontairement.
- [ ] D. ils figurent dans le chapitre des défenses.
- [ ] E. ils excluent toute angoisse.

DIFFICILE

Q38 · Quelle distinction est correcte entre isolation, refoulement et dénégation ?

- [ ] A. L'isolation sépare un affect d'une représentation qui reste consciente.
- [ ] B. Le refoulement rejette certaines représentations conflictuelles dans l'inconscient.
- [ ] C. La dénégation consiste à refuser comme siens des contenus venant d'être exprimés.
- [ ] D. Les trois notions sont totalement identiques.
- [ ] E. Elles constituent des diagnostics psychiques suffisants.

MOYEN

Q39 · À propos de l'activisme, de la combativité et du retrait apathique…

- [ ] A. l'activisme recourt à l'action plutôt qu'au vécu des affects.
- [ ] B. la combativité peut être une forme d'activisme.
- [ ] C. le retrait apathique se présente comme une protection par détachement.
- [ ] D. ces réactions doivent être jugées négativement dans tous les cas.
- [ ] E. la combativité garantit la guérison somatique.

DIFFICILE

Q40 · L'affiliation présentée comme mécanisme de défense…

- [ ] A. cherche l'aide et le soutien d'autrui en situation anxiogène.
- [ ] B. correspond exactement à toutes les définitions d'affiliation en psychologie sociale.
- [ ] C. est à distinguer du concept social de formation des liens.
- [ ] D. peut être mobilisée pour faire face à une épreuve.
- [ ] E. est synonyme d'isolement obligatoire.

DIFFICILE

Q41 · La sublimation et l'humour sont abordés dans les défenses. Quelles propositions sont justes ?

- ☐ A. La sublimation peut dériver une pulsion vers des activités valorisées.
- ☐ B. L'humour appliqué à soi-même peut avoir une fonction défensive.
- ☐ C. La sublimation se résume à une perte de mémoire.
- ☐ D. La notion de sublimation comporte deux acceptions distinctes.
- ☐ E. L'humour signifie nécessairement se moquer du patient.

THÈME • Annonce du diagnostic

FACILE

Q42 · La définition complète de l'annonce du diagnostic donnée par Mme Katir comporte…

- ☐ A. l'acte médical d'informer le patient.
- ☐ B. un choc psychologique possible et un bouleversement.
- ☐ C. la prise en compte du patient et de ses proches.
- ☐ D. une simple formalité administrative sans conséquence.
- ☐ E. la certitude que tous les patients vont réagir de la même façon.

MOYEN

Q43 · Concernant les réactions décrites après une annonce…

- ☐ A. le cours évoque la sidération et le déni.
- ☐ B. il évoque colère, marchandage, état dépressif et acceptation.
- ☐ C. l'ordre des réactions est imposé pour chaque personne.
- ☐ D. une même personne peut ne pas traverser chaque étape.
- ☐ E. le soignant doit imposer rapidement l'acceptation.

MOYEN

Q44 · Une patiente devient silencieuse après l'annonce. Quelles hypothèses prudentes sont recevables ?

- ☐ A. Une sidération est possible.
- ☐ B. Le silence prouve qu'elle a compris et accepté.
- ☐ C. Une réaction de protection psychique peut être en jeu.
- ☐ D. Il faut observer, écouter et proposer un soutien.
- ☐ E. Il faut immédiatement conclure à un trouble psychiatrique.

DIFFICILE

Q45 · Dans l'accompagnement des proches lors d'une annonce…

- ☐ A. leur bouleversement peut être reconnu.
- ☐ B. le patient doit rester une personne sujet de la prise en charge.
- ☐ C. la confidentialité doit être respectée.
- ☐ D. les proches reçoivent systématiquement toute information sans accord.
- ☐ E. la défense du patient doit toujours être éliminée.

THÈME • Corps, schéma et image

FACILE

Q46 · Le corps-objet et le corps-sujet diffèrent car…

- ☐ A. le corps-objet est étudié biologiquement et médicalement.
- ☐ B. le corps-sujet renvoie au corps vécu et à son histoire.
- ☐ C. le corps-sujet se réduit aux organes mesurables.
- ☐ D. les deux termes désignent deux regards sur la personne.
- ☐ E. le corps-objet interdit toute écoute clinique.

MOYEN

Q47 · Le schéma corporel désigne…

- ☐ A. des repères sensoriels et moteurs.
- ☐ B. la capacité de se situer et de mobiliser son corps.
- ☐ C. uniquement l'estime esthétique de son apparence.
- ☐ D. des composantes posturales.
- ☐ E. exactement le même concept que l'image du corps.

MOYEN

Q48 · L'image du corps renvoie notamment…

- ☐ A. à une représentation subjective du corps.
- ☐ B. à la valeur affective et personnelle attribuée à son apparence.
- ☐ C. uniquement à la liste des muscles.
- ☐ D. à l'histoire et au regard d'autrui.
- ☐ E. au même sens que le schéma corporel.

MOYEN

Q49 · À propos de l'amputation et du membre fantôme…

- ☐ A. un membre absent peut encore être ressenti.
- ☐ B. la douleur de membre fantôme peut exister.
- ☐ C. le vécu corporel n'est pas réduit à l'état anatomique présent.
- ☐ D. cette douleur permet d'accuser le patient d'inventer.
- ☐ E. cela prouve nécessairement une atteinte mentale.

DIFFICILE

Q50 · Que signifie une approche psychosomatique prudente ?

- ☐ A. Considérer l'histoire et les dimensions psychiques et corporelles ensemble.
- ☐ B. Déduire qu'une personne a créé sa maladie par la pensée.
- ☐ C. Maintenir une recherche médicale des causes organiques.
- ☐ D. Ne pas culpabiliser le patient.
- ☐ E. Écarter toute dimension relationnelle.

Corrigés argumentés

THÈME • Santé et qualité de vie

Q01 — Réponses : B, C, E. La psychologie de la santé adopte une approche biopsychosociale : elle relie facteurs personnels, sociaux, prévention, vécu et trajectoire de soin. Elle ne se limite ni à l'organe ni au médicament.

Q02 — Réponses : A, C, E. La définition de l'OMS dépasse l'absence d'affection et prend en compte trois dimensions ; le cours en discute la dimension idéale et relativement statique.

Q03 — Réponses : A, C, D. La santé perçue appartient au point de vue du sujet ; elle n'est pas réductible aux mesures biomédicales.

Q04 — Réponses : A, B, C. La qualité de vie comporte des dimensions physique, psychique, sociale et environnementale ; sa mesure ne peut se résumer aux constantes ou au traitement.

Q05 — Réponses : A, C, E. La qualité de vie ne dépend pas mécaniquement de la présence d'un diagnostic : autonomie, sens, soutien et ressources comptent.

Q06 — Réponses : A, C, E. Comparer sans hiérarchisation automatique permet de comprendre les écarts de perspectives et d'adapter l'accompagnement.

THÈME • Maladie, douleur et représentations

Q07 — Réponses : A, C. Illness renvoie à ce que le patient éprouve et raconte ; disease renvoie à la dimension biomédicale, sickness à la dimension sociale.

Q08 — Réponses : A, B, C. Sickness décrit le statut et les conséquences sociales de la maladie ; elle diffère des processus biologiques et de l'expérience intime.

Q09 — Réponses : A, C, E. Le cours insiste sur l'expérience sensorielle et émotionnelle : la douleur existe aussi sans lésion objectivable.

Corrigés argumentés — suite

Q10 — Réponses : A, C, E. L'absence de lésion visible n'annule pas la douleur. Elle n'autorise ni accusation de simulation ni réduction psychologique automatique.

Q11 — Réponses : A, B, C. Les représentations explorent cause, identité, conséquences, temporalité, contrôle et traitement ; ce sont des croyances du patient.

Q12 — Réponses : A, C, E. Comprendre la représentation ne signifie pas la valider comme étiologie ; cela permet d'identifier les obstacles et de dialoguer.

THÈME • Déterminants et modèle intégratif

Q13 — Réponses : A, B, C. Il distingue des facteurs de risque initiaux, l'évaluation et les stratégies de la personne, puis les conséquences d'ajustement.

Q14 — Réponses : A, C, D. La notion est probabiliste et contextuelle ; antécédents, vulnérabilité, déclencheurs et protection ne se confondent pas.

Q15 — Réponses : A, B, C. Les conditions matérielles, sociales, professionnelles et l'accès au soin influencent les trajectoires de santé.

Q16 — Réponses : A, B, C. Les processus transactionnels modulent l'effet des facteurs initiaux ; le vécu est dynamique, non mécanique.

THÈME • Soutien social

Q17 — Réponses : A, C. Un réseau est un ensemble de liens ; la taille du réseau ne prouve pas le caractère adapté du soutien reçu ou perçu.

Q18 — Réponses : A, C, E. Le soutien perçu est une évaluation subjective de la disponibilité et de l'adéquation de l'aide, distincte du soutien reçu.

Corrigés argumentés — suite

Q19 — Réponses : A, B, E. Le reçu est l'aide effective ; le mobilisé désigne des efforts pour obtenir de l'aide ; le perçu renseigne le sentiment d'être soutenu.

Q20 — Réponses : A, B, C. Le soutien peut être instrumental, émotionnel, informatif ou lié à la reconnaissance et à l'intégration sociale.

Q21 — Réponses : A, C, D. Le soutien social n'est pas une simple quantité de liens : sa disponibilité, sa pertinence et son vécu méritent une exploration.

THÈME • Vulnérabilité et résilience

Q22 — Réponses : A, B, C. Le cours distingue les composantes personnelles et environnementales : elles interagissent sans condamnation mécanique.

Q23 — Réponses : A, C, D. Le concept concerne le développement et l'ajustement malgré l'adversité, sans nier l'épreuve ni promettre une guérison émotionnelle.

Q24 — Réponses : A, C, D. Mme Katir demande les définitions entières, en phrases rédigées. Les différentes références décrivent la construction malgré des conditions adverses.

Q25 — Réponses : A, C, E. Le repère historique sert à montrer des trajectoires différenciées, influencées par les ressources personnelles et protectrices.

Q26 — Réponses : A, B, D. Le cours mobilise ces notions comme facteurs pouvant influer sur le stress et les relations, sans causalité individuelle simpliste.

THÈME • Stress et coping

Q27 — Réponses : A, C, E. L'évaluation primaire caractérise ce que représente l'événement ; les ressources sont évaluées principalement lors de l'évaluation secondaire.

Corrigés argumentés — suite

Q28 — Réponses : A, B, C. Elle examine les moyens d'action et les ressources perçues, sans garantir un contrôle complet.

Q29 — Réponses : A, C, D. Le contrôle perçu désigne un sentiment de capacité d'action ; il peut soutenir l'ajustement sans supprimer les limites réelles.

Q30 — Réponses : A, B, C. Ce coping vise à agir sur la situation ou à renforcer les ressources pour y faire face.

Q31 — Réponses : A, B, C. Le coping émotionnel cherche à modifier la manière de vivre l'émotion ; la réévaluation positive ne supprime pas les faits.

Q32 — Réponses : A, B, C. Ce registre rassemble des efforts actifs de recherche d'un soutien émotionnel, informatif ou pratique.

Q33 — Réponses : A, B, D. Coping et défense sont des cadres différents, et l'évaluation de leurs effets tient compte du contexte, de la durée et des conséquences.

THÈME • Angoisse et mécanismes de défense

Q34 — Réponses : A, C, D. Ils peuvent avoir une fonction protectrice dans l'épreuve ; ils ne sont pas des indices de faute ou de mauvaise volonté.

Q35 — Réponses : A, C, D. Le déni peut amortir un choc ; il doit être observé avec discernement et pris en compte s'il compromet des soins essentiels.

Q36 — Réponses : A, C, E. La projection déplace vers autrui certains contenus psychiques ; son interprétation ne se déduit toutefois pas d'un reproche isolé.

Corrigés argumentés — suite

Q37 — Réponses : A, B, D. La régression et la rationalisation sont deux mécanismes de défense différents, mobilisables face à des conflits ou à l'angoisse.

Q38 — Réponses : A, B, C. Les trois mécanismes agissent différemment sur le rapport aux affects et représentations. On ne pose pas de diagnostic sur une seule parole.

Q39 — Réponses : A, B, C. Ces mécanismes peuvent protéger contre l'angoisse ; leur fonction dépend du contexte et ne constitue jamais une garantie médicale.

Q40 — Réponses : A, C, D. Dans ce chapitre, l'affiliation concerne un mouvement de recherche de soutien protecteur face à l'angoisse, différent de la psychosociologie.

Q41 — Réponses : A, B, D. La sublimation peut être comprise selon deux acceptions ; l'humour appliqué à soi-même est une modalité particulière de transformation de ce qui provoque de l'angoisse.

THÈME • Annonce du diagnostic

Q42 — Réponses : A, B, C. La définition inclut explicitement le choc, l'épreuve et le traumatisme psychique potentiel, en plus de l'acte d'annonce.

Q43 — Réponses : A, B, D. Les réactions présentées sont des repères pédagogiques, pas un calendrier universel ni un moyen d'étiqueter les patients.

Q44 — Réponses : A, C, D. Le silence peut notamment refléter une sidération ; on ne peut pas en déduire une compréhension, une émotion certaine ou un diagnostic.

Q45 — Réponses : A, B, C. L'impact relationnel est important, mais il ne retire ni la place du patient ni les exigences de respect et de confidentialité.

THÈME • Corps, schéma et image

Corrigés argumentés — suite

Q46 — Réponses : A, B, D. Le cours oppose deux perspectives complémentaires : corps observable et corps singulier vécu dans une histoire psychique et relationnelle.

Q47 — Réponses : A, B, D. Le schéma corporel est sensorimoteur et postural ; l'image du corps est une représentation subjective et affective.

Q48 — Réponses : A, B, D. Elle associe représentation psychique, affects, identité et relations, au-delà des repères sensorimoteurs.

Q49 — Réponses : A, B, C. L'exemple illustre un décalage possible entre l'intégrité anatomique et l'expérience corporelle vécue.

Q50 — Réponses : A, C, D. Le cours invite à une lecture globale sans causalité psychique abusive et sans renoncer aux soins somatiques.